Estilo UERJ

Simulado 2 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 80 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 4 horas, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 67 anos, submetida há 7 semanas a troca valvar aórtica por prótese biológica, procura o pronto-socorro por febre de 38,5 °C há 10 dias, calafrios e astenia. No pós-operatório teve deiscência superficial da ferida esternal, tratada com curativos. Há 3 semanas fez extração de dois molares, sem antibiótico profilático. Nega uso recente de antibióticos. Exame: T 38,4 °C, FC 102 bpm, PA 112 × 70 mmHg, ferida esternal cicatrizada, sopro sistólico ejetivo 2+/6 em foco aórtico e sopro diastólico aspirativo novo em borda esternal esquerda; sem petéquias ou esplenomegalia. Três pares de hemoculturas colhidos, ainda sem crescimento. Ecocardiograma transesofágico: abscesso perivalvar aórtico e regurgitação paraprotética moderada. Enquanto se aguarda a identificação, o agente mais provável e que deve orientar o esquema empírico é:

A) Estafilococo coagulase-negativo

B) Estreptococo do grupo viridans

C) Enterococcus faecalis

D) Bactéria do grupo HACEK

---

2 Mulher de 49 anos, em quimioterapia adjuvante para carcinoma de mama (docetaxel e ciclofosfamida, último ciclo há 9 dias, sem profilaxia antimicrobiana), procura o pronto-atendimento com febre de 38,4 °C iniciada em casa há 6 horas. Refere mal-estar leve; sem tosse, disúria, diarreia ou dor. Não tem DPOC, nunca teve infecção fúngica e não está desidratada. Exame: bom estado geral, PA 122 × 78 mmHg, FC 96 bpm, FR 16 irpm, SpO2 98% em ar ambiente, sem foco infeccioso, cateter totalmente implantado sem sinais flogísticos. Exames: neutrófilos 380/mm³, creatinina 0,7 mg/dL, bilirrubinas e transaminases normais, lactato 1,1 mmol/L; radiografia de tórax e urina tipo 1 normais. Mora a 15 minutos do hospital, com acompanhante e telefone. Colhidas as hemoculturas, a conduta mais adequada é:

A) Internar e iniciar cefepime intravenoso

B) Internar com piperacilina-tazobactam e vancomicina

C) Alta sem antibiótico, aguardando culturas

D) Ciprofloxacino e amoxicilina-clavulanato orais

---

3 Homem de 54 anos, com diabetes tipo 2 há seis anos em metformina e empagliflozina (HbA1c 7,1%), hipertensão e IMC de 33 kg/m², é encaminhado porque a ultrassonografia de abdome, pedida por dor lombar, descreveu esteatose hepática moderada. Consome cerca de duas doses de álcool por semana. Nega uso de amiodarona, metotrexato ou corticoide. Exame: sem estigmas de hepatopatia crônica, baço não palpável. Exames: AST 34 U/L (até 40), ALT 71 U/L (até 41), GGT 88 U/L, plaquetas 268.000/mm³, albumina 4,4 g/dL, HBsAg e anti-HCV negativos, ferritina 210 ng/mL com saturação de transferrina 29%. O índice FIB-4 calculado foi 0,81. Além de reforçar a perda de peso, o próximo passo mais adequado na avaliação da fibrose hepática é:

A) Biópsia hepática percutânea

B) Repetir o FIB-4 em um a dois anos

C) Elastografia hepática transitória

D) Encaminhamento ao hepatologista

---

4 Homem de 34 anos procura atendimento por lesões dolorosas e escurecidas nas orelhas e nas bochechas há 10 dias, com artralgias de mãos e joelhos. Há 6 meses tem obstrução nasal com crostas e epistaxe ocasional. Usa cocaína inalada nos fins de semana há 5 anos e nega outras drogas ou medicações. Exame físico: T 37,4 °C, PA 124 × 78 mmHg, púrpura retiforme com centro necrótico nas hélices das duas orelhas e nas regiões malares, perfuração do septo nasal anterior, sem sinovite, ausculta pulmonar normal. Exames: Hb 12,6 g/dL, leucócitos 2.300/mm³ (neutrófilos 450/mm³), plaquetas 205.000/mm³, creatinina 0,9 mg/dL, EAS sem hematúria e sem proteinúria, p-ANCA reagente 1:1.280 com anti-MPO 160 U/mL e anti-PR3 42 U/mL (VR < 20 para ambos), anticoagulante lúpico reagente, crioglobulinas negativas, anti-HCV e anti-HIV não reagentes. TC de tórax normal; TC de seios da face com perfuração septal, sem erosão de seios paranasais ou da órbita. O diagnóstico mais provável é:

A) Poliangeíte microscópica

B) Vasculopatia por levamisol

C) Granulomatose com poliangeíte

D) Vasculite crioglobulinêmica

---

5 Mulher de 58 anos procura o clínico por "ínguas" no pescoço e na virilha percebidas há 1 ano, sem crescimento desde então. Nega febre, sudorese noturna e perda de peso. Exame: linfonodos cervicais e inguinais bilaterais de 1,5 a 2,5 cm, fibroelásticos e indolores; baço não palpável. Exames: Hb 13,1 g/dL, leucócitos 6.400/mm³, plaquetas 210.000/mm³, LDH 190 U/L (VR até 250), beta-2-microglobulina normal. Biópsia excisional de linfonodo inguinal: proliferação nodular de células B pequenas clivadas, CD20+, CD10+, BCL2+, CD5 negativo, ciclina D1 negativa, Ki-67 de 10%. PET-CT: linfonodos cervicais, axilares, mediastinais e ilíacos, apenas um acima de 3 cm (o maior com 3,2 cm), SUV máximo de 6. Biópsia de medula óssea com infiltração paratrabecular de 15%. O diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

A) Linfoma do manto / R-quimioterapia

B) Linfoma do manto / observação vigilante

C) Linfoma folicular / R-quimioterapia

D) Linfoma folicular / observação vigilante

---

6 Ensaio clínico randomizado comparou uma droga a placebo em pacientes de alto risco cardiovascular e os acompanhou por 5 anos. A taxa de AVC foi de 2,0 por 100 pacientes-ano no grupo placebo e de 1,5 por 100 pacientes-ano no grupo tratado, constante ao longo do seguimento. O número de pacientes que é preciso tratar durante os 5 anos para evitar um AVC é, aproximadamente:

A) 40

B) 4

C) 25

D) 200

---

7 Homem de 74 anos, com diabetes tipo 2 e doença renal crônica (TFGe 24 mL/min/1,73 m²), em uso de glibenclamida 10 mg/dia e losartana, é trazido pela filha após crise tônico-clônica generalizada de cerca de 2 minutos, em casa, às 6 h. Ela conta que ele quase não jantou na véspera por diarreia. Na chegada, 40 minutos depois, está confuso e sudoreico, sem déficit focal, PA 150/90 mmHg, FC 104 bpm, Tax 36,4 °C. Glicemia capilar 34 mg/dL. Recebeu 50 mL de glicose a 50% IV, com recuperação completa da consciência em 10 minutos. Sódio 138 mEq/L, cálcio 9,2 mg/dL, creatinina 2,6 mg/dL. TC de crânio sem contraste: atrofia compatível com a idade. Nunca teve crise antes. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Levetiracetam oral por seis meses

B) Fenitoína IV em dose de ataque

C) Alta após refeição, sem glibenclamida

D) Internação com glicose IV contínua

---

8 Homem de 63 anos, no 4º dia de infarto inferior tratado com angioplastia da coronária direita realizada 14 horas após o início da dor, evolui subitamente com dispneia intensa e hipotensão. Exame: PA 84×54 mmHg, FC 118 bpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores até ápices, sopro holossistólico de intensidade 3/6, mais audível na borda esternal esquerda baixa e na base, sem frêmito palpável. Cateter de artéria pulmonar: saturação de O2 de 58% no átrio direito e de 59% na artéria pulmonar; pressão de oclusão com ondas v de 48 mmHg. Radiografia: congestão pulmonar bilateral. O diagnóstico mais provável é:

A) Infarto de ventrículo direito

B) Ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo

C) Comunicação interventricular pós-infarto

D) Ruptura de músculo papilar

---

9 Homem de 74 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 28%) em uso de sacubitril-valsartana, carvedilol, espironolactona, dapagliflozina e furosemida 40 mg/dia, é internado por dispneia aos mínimos esforços e ganho de 5 kg em duas semanas. Por conselho de um vizinho, passou a beber pelo menos três litros de água por dia para proteger os rins. Exame: lúcido, sem déficits, PA 104/68 mmHg, FC 92 bpm, turgência jugular a 45 graus, estertores até o terço médio de ambos os hemitórax e edema 3+ até as coxas. Exames: sódio 124 mEq/L (era 136 mEq/L há dois meses), potássio 4,6 mEq/L, ureia 68 mg/dL, creatinina 1,4 mg/dL (basal 1,2), glicemia 110 mg/dL, osmolalidade plasmática 262 mOsm/kg, osmolalidade urinária 410 mOsm/kg e sódio urinário de 18 mEq/L, colhido 22 horas após a última dose de furosemida. O mecanismo da hiponatremia e a conduta são, respectivamente:

A) Hipervolemia / restrição hídrica e furosemida IV

B) Hipervolemia / suspender furosemida e salina isotônica

C) Hipovolemia por diurético / restrição hídrica e furosemida IV

D) Hipovolemia por diurético / suspender furosemida e salina isotônica

---

10 Após o tratamento de erradicação do Helicobacter pylori em paciente com úlcera duodenal não complicada, o exame de controle de cura e a conduta quanto ao inibidor de bomba de prótons antes dele são, respectivamente:

A) Teste respiratório com ureia / suspender IBP 2 semanas antes

B) Sorologia IgG / manter IBP

C) Teste respiratório com ureia / manter IBP até o exame

D) Sorologia IgG / suspender IBP 2 semanas antes

---

11 Mulher de 27 anos, gestante de 16 semanas, procura a UBS porque a irmã, com quem mora, teve sarampo confirmado por RT-PCR. As duas dividiram o quarto até a irmã ser internada em isolamento há 4 dias, no mesmo dia em que surgiu o exantema. A gestante está assintomática e não tem comprovante de vacinação; a sorologia IgG para sarampo, colhida hoje, é não reagente. Nega imunodeficiência e alergias. A conduta mais adequada para ela, segundo o Ministério da Saúde, é:

A) Vitamina A em dose de ataque

B) Observação, sem profilaxia

C) Imunoglobulina humana normal

D) Vacina tríplice viral hoje

---

12 Mulher de 36 anos procura o clínico com o resultado de exames pedidos pela dermatologista, que acompanha queda de cabelo e unhas quebradiças há quatro meses e prescreveu um suplemento manipulado em dose alta, em uso diário desde então. Nega palpitação, tremor, perda de peso, intolerância ao calor ou alteração do ritmo intestinal. Exame: FC 74 bpm, PA 118/72 mmHg, tireoide de volume normal, sem nódulos, sem oftalmopatia, pele e reflexos normais. Exames: TSH 0,04 µUI/mL (0,4 a 4,5), T4 livre 3,1 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 240 ng/dL (80 a 200), anticorpo antirreceptor de TSH (TRAb) 4,2 UI/L (até 1,75). Hemograma e ferritina normais. A explicação mais provável para esses exames é:

A) Tireoidite indolor em fase tireotóxica

B) Tireotoxicose factícia por hormônio no suplemento

C) Doença de Graves em fase inicial

D) Artefato analítico do imunoensaio

---

13 Mulher de 61 anos, ex-tabagista (20 maços-ano), procura atendimento por dispneia que progrediu em 5 semanas de grandes para pequenos esforços, com tosse seca. Há 3 meses notou lesões violáceas nas pálpebras, pápulas dolorosas e ulceradas nas faces palmares das articulações interfalângicas, úlceras nas polpas digitais, artralgia em mãos e queda de cabelo. Perdeu 5 kg. Nega fraqueza para subir escadas ou pentear os cabelos. Exame físico: SpO2 89% em ar ambiente, FR 26 irpm, estertores em velcro bibasais, força muscular grau 5 nos quatro membros, heliotropo e eritema em V no decote. Exames: CK 190 U/L (VR até 170), aldolase normal, ferritina 2.300 ng/mL, AST 88 U/L, linfócitos 600/mm³. TC de tórax: consolidações e vidro fosco subpleurais e peribroncovasculares em bases, ausentes em radiografia de 2 meses antes. O autoanticorpo mais provável e a conduta prioritária neste momento são, respectivamente:

A) Anti-TIF1-gama / rastreio de neoplasia oculta

B) Anti-TIF1-gama / imunossupressão combinada imediata

C) Anti-MDA5 / rastreio de neoplasia antes de imunossuprimir

D) Anti-MDA5 / imunossupressão combinada imediata

---

14 Homem de 20 anos, com anemia falciforme (HbSS) e hemoglobina basal de 8,2 g/dL, em uso de ácido fólico, procura a emergência por cansaço intenso e tontura há 4 dias. Há 10 dias teve febre baixa, coriza e dor nas pernas, que tratou em casa com dipirona como "crise leve". Sem dor óssea atual e sem dor torácica. Exame: FC 118 bpm, PA 100 × 60 mmHg, SpO2 97%, icterícia 1+/4, mucosas muito descoradas, baço não palpável, fígado a 2 cm do rebordo. Exames: Hb 3,9 g/dL, VCM 92 fL, reticulócitos 0,2% (basal de 9%), leucócitos 8.900/mm³, plaquetas 260.000/mm³, LDH 520 U/L, bilirrubina indireta 2,1 mg/dL. A causa mais provável da queda da hemoglobina é:

A) Sequestro esplênico agudo

B) Hemólise aumentada pela crise vaso-oclusiva

C) Aplasia eritroide por parvovírus B19

D) Deficiência aguda de folato

---

15 Mulher de 34 anos, ex-tabagista de 8 maços-ano, procura atendimento por febre baixa, dor e edema em ambos os tornozelos há 3 semanas e nódulos dolorosos e eritematosos na face anterior das pernas. Nega tosse, dispneia, perda de peso, sudorese noturna e contato com tuberculose. Exame: T 37,7 °C, periartrite de tornozelos bilateral, nódulos subcutâneos dolorosos em região pré-tibial, sem linfonodos periféricos palpáveis, sem hepatoesplenomegalia. Radiografia de tórax: alargamento hilar bilateral simétrico, sem infiltrado. TC: linfonodomegalias hilares bilaterais e paratraqueais direitas de até 2,2 cm, sem lesão parenquimatosa. Hemograma normal, cálcio 9,6 mg/dL, ECA 88 U/L (VR até 52). Espirometria e DLCO normais. Exame oftalmológico normal. A conduta mais adequada é:

A) Ecobroncoscopia com punção linfonodal

B) Prednisona 20 a 40 mg/dia

C) Metotrexato semanal

D) Anti-inflamatório e seguimento clínico

---

16 Homem de 46 anos, etilista de 80 g/dia, está internado há 16 dias por pancreatite aguda grave (falência respiratória transitória nas primeiras 36 horas, já resolvida). Recebe dieta por sonda nasojejunal desde o 3º dia, com boa tolerância, e a dor está controlada com dipirona. Hoje: Tax 37,6 °C, FC 92 bpm, PA 128 × 76 mmHg, SpO2 96% em ar ambiente, abdome com dor leve à palpação profunda do epigástrio, sem distensão. Exames: leucócitos 11.800/mm³ (estáveis há 5 dias), PCR 68 mg/L (era 290 mg/L no 3º dia), procalcitonina 0,2 ng/mL, creatinina 0,9 mg/dL; hemoculturas negativas. TC com contraste: necrose de 40% do corpo pancreático e coleção heterogênea de 9 cm adjacente ao estômago, com conteúdo não liquefeito, sem parede definida e sem gás. A classificação da coleção e a conduta mais adequada neste momento são, respectivamente:

A) Pseudocisto / drenagem endoscópica

B) Coleção necrótica aguda / drenagem percutânea

C) Coleção necrótica aguda / suporte clínico

D) Pseudocisto / suporte clínico

---

17 Mulher de 19 anos é encaminhada por amenorreia primária. Mede 1,44 m, tem pescoço curto com pterígio, implantação baixa dos cabelos na nuca, tórax largo com mamilos afastados, cúbito valgo e quarto metacarpo curto bilateral. Nega dispneia, síncope, cefaleia ou dor torácica. Exame: PA no braço direito 156×94 mmHg, FC 76 bpm, ritmo regular, ictus no 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular. FSH 98 mUI/mL e estradiol indetectável; creatinina 0,7 mg/dL e urina normal. Ainda não fez ecocardiograma. Ao completar o exame cardiovascular, o conjunto de achados mais provável é:

A) Desdobramento fixo de B2 e sopro ejetivo pulmonar

B) Sopro contínuo em maquinária infraclavicular esquerdo

C) Clique mesossistólico e sopro telessistólico apical

D) Clique ejetivo aórtico e sopro sistólico interescapular

---

18 Homem de 63 anos, pedreiro aposentado, com cervicalgia mecânica há anos, tem fraqueza progressiva na mão direita há 8 meses, depois na esquerda, e câimbras frequentes nas panturrilhas. Nega parestesias, alteração esfincteriana, engasgos e alteração da voz. Exame: atrofia de interósseos e tenar bilateral, fasciculações em ambos os deltoides e nas panturrilhas, língua com atrofia de bordas e fasciculações em repouso, reflexos bicipitais e patelares vivos, Hoffmann bilateral, sensibilidade tátil, dolorosa e vibratória normais. RM de coluna cervical solicitada pelo clínico: discopatia degenerativa com estenose do canal em C5-C6, sem hipersinal medular em T2. O ortopedista indica descompressão. O próximo passo mais adequado é:

A) Eletroneuromiografia com agulha

B) Anticorpo anti-GM1 sérico

C) Descompressão cirúrgica de C5-C6

D) RM de encéfalo com contraste

---

19 Médica veterinária de 34 anos, com esquema completo de profilaxia pré-exposição antirrábica há 3 anos, é mordida no dorso da mão por um morcego durante captura em uma fazenda. A ferida foi lavada com água e sabão. Pelas normas do Ministério da Saúde, a indicação de soro (ou imunoglobulina) antirrábico e o número de doses de vacina são, respectivamente:

A) Não indicado / 4 doses

B) Não indicado / 2 doses

C) Indicado / 4 doses

D) Indicado / 2 doses

---

20 Homem de 58 anos, em hemodiálise três vezes por semana por doença renal do diabetes, faltou às duas últimas sessões e chega com fraqueza nas pernas há seis horas. Exame: lúcido, PA 134/80 mmHg, FC 46 bpm, SpO2 95% em ar ambiente, sem estertores, edema 1+. ECG: ausência de onda P, QRS de 160 ms e ondas T apiculadas. Exames: potássio 7,6 mEq/L, glicemia 214 mg/dL, bicarbonato 17 mEq/L. Recebeu 30 mL de gluconato de cálcio a 10% IV em dez minutos e 10 UI de insulina regular com 25 g de glicose IV. Cinco minutos após o fim da infusão de cálcio, o ECG mantém QRS de 150 ms e FC de 48 bpm. A sala de hemodiálise estará disponível em 60 minutos. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Bicarbonato de sódio a 8,4% IV

B) Nova dose de gluconato de cálcio

C) Nova dose de insulina com glicose

D) Aguardar a hemodiálise monitorizado

---

21 Homem de 63 anos, com gota tofácea há 12 anos em uso irregular de alopurinol, diabetes tipo 2 e doença renal crônica estágio 3a, procura atendimento por dor e edema no joelho direito há 2 dias, semelhante às crises anteriores, mas sem melhora com a colchicina tomada desde o início. Exame físico: T 38,2 °C, FC 104 bpm, joelho direito com derrame volumoso, calor e rubor, tofos em cotovelos. Exames: leucócitos 14.800/mm³, PCR 19 mg/dL, ácido úrico 9,1 mg/dL. Artrocentese: líquido turvo, 86.000 leucócitos/mm³ com 94% de neutrófilos, cristais de urato monossódico intracelulares em agulha com birrefringência negativa, Gram sem bactérias, cultura em andamento. A conduta mais adequada é:

A) Prednisona oral e manter colchicina

B) Drenagem articular e antibiótico venoso

C) Corticoide intra-articular

D) Canaquinumabe subcutâneo

---

22 Homem de 67 anos, com miocardiopatia isquêmica (FE 35%) e taquicardia ventricular, usa amiodarona 200 mg/dia há três anos, além de carvedilol, sacubitril-valsartana e espironolactona. Há três semanas tem piora da dispneia, perda de 3 kg e retorno de palpitações. Função tireoidiana antes da amiodarona normal, com anti-TPO negativo e sem bócio. Exame: FC 108 bpm, irregular, PA 104/66 mmHg, tireoide de volume normal, indolor, sem nódulos. Exames: TSH abaixo de 0,01 µUI/mL, T4 livre 4,2 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 190 ng/dL (80 a 200), TRAb negativo, VHS 22 mm/h. Ultrassonografia com Doppler: tireoide homogênea, de volume normal, com fluxo ausente. Captação de iodo radioativo em 24 horas: 1%. O mecanismo da tireotoxicose e o tratamento são, respectivamente:

A) Síntese aumentada / metimazol

B) Destruição folicular / metimazol

C) Síntese aumentada / prednisona

D) Destruição folicular / prednisona

---

23 Homem de 23 anos é avaliado no pré-operatório de colecistectomia por colelitíase sintomática. Refere "olhos amarelados" em episódios desde a infância, que pioram nas gripes. A mãe foi esplenectomizada na juventude, por motivo que ele desconhece. Usa apenas dipirona eventual. Exame: icterícia 1+/4, baço palpável a 3 cm do rebordo costal. Exames: Hb 11,2 g/dL, VCM 84 fL, CHCM 37,8 g/dL (VR 32 a 36), RDW 17%, reticulócitos 8%, LDH 410 U/L, bilirrubina indireta 3,1 mg/dL, haptoglobina 12 mg/dL (baixa), teste de Coombs direto negativo, dosagem de G6PD normal. Esfregaço: microesferócitos frequentes, sem esquizócitos. O diagnóstico mais provável é:

A) Deficiência de piruvato quinase

B) Anemia hemolítica autoimune quente

C) Síndrome de Gilbert com colelitíase

D) Esferocitose hereditária

---

24 Homem de 57 anos, com doença hepática por álcool, abstinente há 2 anos, hipertenso em uso de losartana, é encaminhado após elastografia hepática transitória de 27 kPa, confirmada em segunda medida em jejum. Nunca teve ascite, icterícia, encefalopatia ou sangramento. Exame: PA 142 × 88 mmHg, FC 82 bpm, IMC 25 kg/m², sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames: plaquetas 138.000/mm³, albumina 4,0 g/dL, bilirrubina 0,9 mg/dL, INR 1,1, creatinina 0,9 mg/dL. Ultrassonografia: fígado de contornos levemente irregulares, sem ascite e sem nódulos. Não há contraindicação a betabloqueador. Para prevenir a primeira descompensação, a conduta mais adequada é:

A) Carvedilol, sem endoscopia de rastreio

B) Endoscopia para rastrear varizes

C) Repetir elastografia em 12 meses

D) Ligadura elástica após endoscopia

---

25 Homem de 74 anos, com cardiomiopatia isquêmica (fração de ejeção de 30%), está internado há 5 dias por dispneia aos mínimos esforços, ortopneia e edema de membros inferiores. Recebe furosemida venosa em dose dobrada desde a admissão, com perda de 6 kg, mas persiste derrame pleural à direita, de volume moderado. Nega febre, tosse produtiva e perda de peso. Exame: PA 108 x 66 mmHg, FC 84 bpm, SpO2 94% em ar ambiente, estertores finos em bases, edema residual em tornozelos. Toracocentese diagnóstica: líquido citrino, proteína 3,3 g/dL, LDH 170 U/L, albumina 1,5 g/dL, glicose 112 mg/dL, pH 7,46, 620 células/mm³ (70% linfócitos e 25% células mesoteliais), ADA 9 U/L. Sangue: proteína total 6,5 g/dL, albumina 3,0 g/dL, LDH 260 U/L (limite superior da normalidade 250 U/L). A interpretação mais adequada do líquido pleural é:

A) Transudato concentrado pelo diurético

B) Transudato por hipoalbuminemia

C) Exsudato por neoplasia pleural

D) Exsudato linfocítico a esclarecer

---

26 Mulher de 71 anos, hipertensa e diabética, em uso de losartana e metformina, procura a UPA no 5º dia de febre, cefaleia, mialgia e dor retro-orbitária, com NS1 reagente no 2º dia. A febre cedeu ontem. Refere náuseas, aceita líquidos e nega sangramentos, vômitos, dor abdominal ou dispneia. Ao levantar-se da maca para ir ao banheiro, teve escurecimento visual e precisou sentar. Exame: T 36,6 °C, FC 92 bpm; PA 128 × 78 mmHg deitada e 104 × 70 mmHg após 3 minutos em pé, com FC de 118 bpm; enchimento capilar de 2 segundos, extremidades quentes, fígado não palpável, sem derrames clinicamente detectáveis; prova do laço negativa. Hematócrito 41% (basal desconhecido), plaquetas 62.000/mm³, creatinina 1,0 mg/dL. Segundo o Ministério da Saúde, a classificação de risco desta paciente é:

A) Grupo D, por choque

B) Grupo C, por sinal de alarme

C) Grupo B, pela idade e comorbidades

D) Grupo A, sem sinais de alarme

---

27 Mulher de 34 anos, 10 semanas após gastrectomia vertical, é admitida por vômitos persistentes há 3 semanas, com perda de 14 kg no período. Nega uso de álcool e de outras substâncias. Há 4 dias está confusa e desatenta, e há 2 dias tem dificuldade para andar e visão dupla. Exame: PA 100/64 mmHg, FC 108 bpm, desidratada, nistagmo horizontal no olhar lateral bilateral, paresia do reto lateral direito, marcha atáxica de base alargada, sem rigidez de nuca. Glicemia capilar 58 mg/dL, sódio 134 mEq/L, potássio 2,9 mEq/L, magnésio 1,2 mg/dL (VR 1,7 a 2,4). A conduta inicial mais adequada é:

A) Tiamina 100 mg oral diária

B) Tiamina 500 mg IV antes da glicose

C) Punção lombar e aciclovir empírico

D) Glicose IV e RM de encéfalo

---

28 Homem de 74 anos recebeu marca-passo definitivo unicameral ventricular (VVI, frequência programada de 70 bpm) há 3 semanas por bloqueio atrioventricular total. Há 10 dias iniciou tansulosina por hiperplasia prostática. É trazido após dois episódios de perda de consciência em 3 dias, o último ao levantar-se à noite para urinar, com recuperação em segundos e sem pródromos. PA 112×60 mmHg deitado e 108×58 mmHg em pé, FC 35 bpm. ECG: espículas de marca-passo regulares a cada 857 ms; complexos QRS largos a 35 bpm, cada um logo após uma espícula; ondas P dissociadas dos QRS. Potássio 4,3 mEq/L. A interpretação do traçado é:

A) Falha de sensibilidade (undersensing)

B) Falha de captura ventricular

C) Marca-passo com função normal

D) Sensibilidade excessiva (oversensing)

---

29 Homem de 63 anos, com diabetes tipo 2 e doença renal crônica (TFGe 38 mL/min/1,73 m², relação albumina/creatinina 620 mg/g), em uso de losartana 100 mg/dia, metformina 500 mg duas vezes ao dia e anlodipino, iniciou empagliflozina 10 mg/dia há quatro semanas. Sem diarreia, vômitos, anti-inflamatório ou contraste. Exame: PA 126/78 mmHg (era 136/82), sem hipotensão postural, sem edema, perdeu 1,5 kg. Exames: creatinina de 1,90 para 2,20 mg/dL (TFGe 32), potássio 4,7 mEq/L (era 5,0), bicarbonato 23 mEq/L, hemoglobina de 12,6 para 13,1 g/dL, urina sem hematúria ou leucocitúria. A explicação para a variação da creatinina e a conduta são, respectivamente:

A) Queda hemodinâmica da filtração / suspender a empagliflozina

B) Queda hemodinâmica da filtração / manter a empagliflozina

C) Lesão tubular aguda / suspender a empagliflozina

D) Lesão tubular aguda / manter a empagliflozina

---

30 Homem de 74 anos com carcinoma pulmonar de não pequenas células metastático, em cuidados exclusivamente paliativos após progressão em duas linhas de tratamento, tem DPOC (VEF1 de 38% do previsto) com PaCO2 basal de 52 mmHg. Está internado por dispneia em repouso, progressiva há 2 semanas, sem febre ou escarro purulento. Já tratados: derrame pleural drenado com pleurodese, broncodilatadores otimizados, ventilador direcionado ao rosto e posicionamento. Exame: lúcido, FR 30 irpm, SpO2 92% com cateter nasal a 2 L/min, sem sibilos, PA 118 × 72 mmHg; PPS 30%. Gasometria: pH 7,37, PaCO2 54 mmHg, bicarbonato 31 mEq/L. Refere a dispneia como 8 em 10 e pede alívio. A conduta mais adequada para o sintoma é:

A) Morfina oral em dose baixa, titulada

B) Aumentar o oxigênio para 5 L/min

C) Evitar opioide pela hipercapnia

D) Diazepam como primeira linha

---

31 Homem de 64 anos, ex-tabagista, procura atendimento por aumento indolor e bilateral das pálpebras superiores há 8 meses, com olhos secos, e dor lombar surda há 3 meses. Tem asma de início há 2 anos e rinossinusite crônica. Nega febre, sudorese noturna, epistaxe, hemoptise, parestesias e lesões de pele. Exame físico: glândulas lacrimais aumentadas, endurecidas e indolores, submandibulares discretamente aumentadas, PA 146 × 90 mmHg, sem linfonodomegalias periféricas. Exames: creatinina 1,9 mg/dL (1,0 há 1 ano), eosinófilos 820/mm³, IgE total 1.100 UI/mL, VHS 64 mm/h, PCR 0,6 mg/dL, c-ANCA e p-ANCA não reagentes, FAN, anti-Ro e anti-La não reagentes, gamaglobulina policlonal de 2,9 g/dL. TC: tecido de partes moles envolvendo a aorta abdominal infrarrenal e as artérias ilíacas, com hidronefrose bilateral, e glândulas lacrimais aumentadas, sem erosão óssea. Na biópsia da glândula lacrimal, o achado esperado é:

A) Granulomas necrosantes com vasculite

B) Infiltrado eosinofílico com vasculite necrosante

C) Infiltrado linfocítico focal periductal

D) Fibrose estoriforme e flebite obliterante

---

32 Homem de 68 anos, em quimioterapia com carboplatina e etoposídeo por carcinoma de pulmão de pequenas células, está no 12º dia do ciclo. Caiu da própria altura há 6 horas e evolui com sonolência e hemiparesia esquerda. Não usa antiagregantes nem anticoagulantes. Exame: Glasgow 12, pupilas isocóricas, PA 150 × 86 mmHg. Tomografia: hematoma subdural agudo frontoparietal direito com 14 mm de espessura e desvio da linha média de 8 mm; a neurocirurgia indica craniotomia de urgência. Exames: Hb 10,1 g/dL, leucócitos 2.400/mm³, plaquetas 64.000/mm³, INR 1,1, TTPa 31 s (controle 30 s), fibrinogênio 310 mg/dL. Em relação à hemostasia, a conduta mais adequada antes da cirurgia é:

A) Operar sem transfusão

B) Plaquetas até acima de 100.000

C) Plasma fresco congelado antes

D) Desmopressina antes da incisão

---

33 Mulher de 63 anos, assintomática, tem hipercalcemia descoberta em exames de rotina e persistente em três dosagens. Nega nefrolitíase, fraturas, uso de tiazídico, lítio ou suplemento de cálcio. Exames: cálcio total 10,8 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 4,2 g/dL, fósforo 2,6 mg/dL, PTH 98 pg/mL (15 a 65), 25-hidroxivitamina D 36 ng/mL, creatinina 0,8 mg/dL (TFG estimada 82 mL/min/1,73 m²), cálcio urinário de 24 horas 240 mg, relação de depuração cálcio/creatinina 0,021. Ultrassonografia renal sem cálculos ou nefrocalcinose. Radiografia de coluna sem fraturas vertebrais. Densitometria: T-score de -1,9 em coluna lombar, -1,6 em colo femoral e -2,7 no terço distal do rádio. A conduta mais adequada é:

A) Cinacalcete e seguimento

B) Paratireoidectomia

C) Alendronato e nova densitometria

D) Seguimento clínico com densitometria anual

---

34 Mulher de 31 anos, com asma desde a infância, chega à emergência com dispneia intensa há 10 horas, iniciada após quadro gripal de 4 dias, com tosse e escarro amarelado espesso. Usa budesonida-formoterol apenas quando tem falta de ar. Fala frases curtas, está sentada inclinada para frente, com uso de musculatura acessória. T 37,2 °C, FC 124 bpm, FR 30 irpm, SpO2 90% em ar ambiente, sibilos difusos, murmúrio simétrico. Pico de fluxo 35% do previsto. Radiografia de tórax: hiperinsuflação, sem consolidação. Após uma hora de salbutamol e ipratrópio inalatórios repetidos, oxigênio e metilprednisolona venosa, o pico de fluxo é de 40%, FR 28 irpm, e ela ainda fala frases curtas, consciente. Gasometria com O2: pH 7,40, PaCO2 41 mmHg, PaO2 68 mmHg. Além de manter o tratamento, a medida mais adequada neste momento é:

A) Sulfato de magnésio intravenoso

B) Amoxicilina-clavulanato

C) Intubação orotraqueal imediata

D) Aminofilina intravenosa

---

35 Homem de 58 anos, hipertenso em uso de anlodipino, é trazido ao pronto-socorro por febre alta, cefaleia intensa holocraniana e vômitos iniciados há 18 horas. Exame: T 39,3 °C, FC 112 bpm, PA 146 x 88 mmHg, Glasgow 15, orientado, rigidez de nuca e sinal de Kernig presentes, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem papiledema à fundoscopia, sem déficit motor ou de pares cranianos. Não há história de crise convulsiva, de doença neurológica prévia, de imunossupressão ou de trauma craniano. Hemoculturas colhidas. O próximo passo mais adequado é:

A) Punção lombar imediata, sem TC

B) TC de crânio antes da punção

C) Antibiótico e punção após 48 horas

D) Ressonância de encéfalo com contraste

---

36 Homem de 68 anos, hipertenso em uso irregular de anlodipino, é trazido ao PS 1 hora e 40 minutos após início súbito, presenciado pela esposa, de hemiparesia direita e afasia. NIHSS 12. Glicemia capilar 136 mg/dL. Usa AAS e clopidogrel desde angioplastia coronária há 8 meses; não usa anticoagulante e não tem cirurgia ou sangramento recente. PA 204/112 mmHg, confirmada em duas medidas com 5 minutos de intervalo, FC 84 bpm, ritmo regular. TC de crânio sem contraste: sem hemorragia, ASPECTS 9. Angiotomografia: sem oclusão de grande vaso. Plaquetas 230.000/mm³. Quanto à pressão arterial e à reperfusão, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Reduzir abaixo de 185/110 / trombectomia

B) Reduzir abaixo de 185/110 / tenecteplase

C) Não reduzir / tenecteplase

D) Não reduzir / sem trombolítico

---

37 Homem de 34 anos, hígido, procura a emergência por dor torácica há 3 dias, em pontada, que piora ao deitar e à inspiração e alivia sentado, iniciada uma semana após resfriado. Não usa anticoagulante, não é imunossuprimido, nega trauma e neoplasia. Exame: Tax 37,6 °C, PA 128×78 mmHg, FC 92 bpm, sem pulso paradoxal, atrito pericárdico. ECG: supradesnivelamento côncavo difuso de ST com infradesnivelamento de PR. Troponina I normal em duas dosagens. PCR 36 mg/L. Ecocardiograma: derrame pericárdico de 6 mm, sem sinais de restrição ao enchimento, função ventricular normal. O plantonista quer interná-lo para pesquisar FAN, PPD, TSH e sorologias virais. O local de tratamento e a investigação etiológica mais adequados são, respectivamente:

A) Ambulatorial / nenhuma investigação adicional

B) Internação / FAN, PPD, TSH e sorologias

C) Ambulatorial / FAN, PPD, TSH e sorologias

D) Internação / nenhuma investigação adicional

---

38 Mulher de 44 anos, etilista de 120 g/dia até a internação, foi admitida há 7 dias com icterícia de 3 semanas, febre baixa e hepatomegalia dolorosa. Na admissão: bilirrubina total 14,2 mg/dL, AST 212 U/L, ALT 88 U/L, TP 24 s (controle 12 s), creatinina 0,8 mg/dL, leucócitos 14.000/mm³. Hemoculturas, urocultura, radiografia de tórax e paracentese diagnóstica sem infecção; sem sangramento digestivo. Com fator discriminante de Maddrey de 61, iniciou prednisolona 40 mg/dia. Hoje, 7º dia de corticoide: lúcida, sem febre, bilirrubina 13,6 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, escore de Lille 0,62. A conduta mais adequada é:

A) Manter prednisolona até 28 dias

B) Suspender a prednisolona

C) Substituir por pentoxifilina

D) Aumentar prednisolona para 60 mg/dia

---

39 Mulher de 61 anos, com diabetes tipo 2 há sete anos (HbA1c 7,1%) e hipertensão, em uso de metformina e losartana 50 mg/dia. Em consulta de seis meses atrás tinha creatinina 0,9 mg/dL, fundoscopia sem retinopatia e relação albumina/creatinina urinária de 18 mg/g. Há cinco semanas usa naproxeno 500 mg duas vezes ao dia por bursite no ombro. Há dez dias tem edema progressivo e ganhou 6 kg. Exame: PA 146/88 mmHg, edema 4+ até a raiz das coxas, sem exantema, sem artrite. Exames: albumina 1,9 g/dL, colesterol total 382 mg/dL, creatinina 1,7 mg/dL, proteinúria de 24 h de 9,8 g, urina com 3 hemácias e 25 leucócitos por campo, sem bactérias, urocultura negativa, C3 e C4 normais, anti-PLA2R não reagente, FAN, HBsAg, anti-HCV e anti-HIV negativos, eletroforese de proteínas sem pico monoclonal. Ultrassonografia: rins de 11 cm. O diagnóstico mais provável é:

A) Lesão mínima com nefrite intersticial

B) Doença renal do diabetes

C) Nefropatia membranosa secundária

D) Glomeruloesclerose segmentar e focal

---

40 Mulher de 58 anos tem esclerose sistêmica cutânea limitada há 11 anos, com Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias e anticorpo anticentrômero reagente. Há 6 meses nota dispneia aos esforços moderados, hoje classe funcional II, sem tosse. Exame físico: SpO2 95% em repouso e 89% ao subir um lance de escada, hiperfonese de B2 em foco pulmonar, sem estertores, sem edema. Provas de função pulmonar: CVF 94% do previsto e DLCO 41% do previsto. TC de tórax de alta resolução sem doença intersticial. Ecocardiograma: velocidade de regurgitação tricúspide de 3,2 m/s, átrio direito aumentado, fração de ejeção do VE de 64%, função diastólica normal, sem valvopatia. Cintilografia de ventilação e perfusão normal. NT-proBNP 610 pg/mL. O próximo exame mais adequado é:

A) Cateterismo cardíaco direito

B) Repetir ecocardiograma em 12 meses

C) Angiotomografia de artérias pulmonares

D) Ecocardiograma sob esforço

---

41 Homem de 26 anos, cujo irmão completou tratamento de tuberculose pulmonar há 1 ano, procura atendimento por febre vespertina, sudorese noturna e perda de 6 kg há 3 meses, com "caroço" no pescoço há 2 meses. Exame: T 37,8 °C, linfonodos supraclaviculares esquerdos coalescentes de 4 cm, indolores, sem fistulização. Radiografia de tórax: alargamento do mediastino anterior, sem lesão parenquimatosa. PPD de 14 mm. Hemograma: Hb 11,4 g/dL, leucócitos 12.800/mm³ com 11% de eosinófilos, linfócitos 700/mm³, plaquetas 450.000/mm³. VHS 88 mm/h. Biópsia excisional: granulomas epitelioides sem necrose caseosa, entremeados a nódulos separados por faixas de colágeno com células grandes binucleadas CD30+ e CD15+, CD20 e CD45 negativas, em fundo de eosinófilos e linfócitos reativos; pesquisa de BAAR e teste molecular para M. tuberculosis negativos. O diagnóstico é:

A) Tuberculose ganglionar

B) Linfoma primário do mediastino de células B

C) Linfoma de Hodgkin clássico

D) Linfoma T periférico

---

42 Homem de 67 anos, com doença renal crônica estágio 3b, chega à emergência com febre, tosse produtiva e confusão há 2 dias. PA 78 × 42 mmHg (PAM 54), FC 122 bpm, FR 28 irpm, SpO2 92% com cateter de O2, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, extremidades frias. Radiografia: consolidação em lobo inferior direito. Exames: lactato 4,6 mmol/L, Na 138 mEq/L, K 5,6 mEq/L, Cl 111 mEq/L, HCO3 14 mEq/L, creatinina 2,8 mg/dL (basal 1,8). Foram colhidas hemoculturas e iniciados ceftriaxona e azitromicina. Recebeu 1.500 mL de soro fisiológico a 0,9% em 40 minutos e está com PAM de 56 mmHg. A passagem do cateter venoso central está prevista para daqui a 2 horas, quando chegar o plantonista da UTI. O cristaloide a manter e o momento de iniciar a noradrenalina são, respectivamente:

A) Ringer lactato / após o cateter central

B) Ringer lactato / imediatamente, em veia periférica

C) Soro fisiológico / após o cateter central

D) Soro fisiológico / imediatamente, em veia periférica

---

43 Mulher de 31 anos traz exames de check-up solicitados pela empresa, que incluíram prolactina por iniciativa do médico do trabalho. Ciclos menstruais regulares a cada 28 dias, sem galactorreia à expressão, sem cefaleia ou queixa visual, libido preservada. Usa apenas omeprazol 20 mg/dia há dois meses por dispepsia. Não usa antidepressivo, antipsicótico, metoclopramida ou anticoncepcional. Exame físico normal. Exames: prolactina 94 ng/mL (até 25), repetida em nova coleta em repouso, 92 ng/mL; beta-hCG negativo; TSH 1,8 µUI/mL; creatinina 0,7 mg/dL. A conduta diagnóstica mais adequada neste momento é:

A) Cabergolina em dose baixa

B) Suspender o omeprazol e repetir a dosagem

C) Pesquisa de macroprolactina

D) Ressonância magnética de sela túrcica

---

44 Homem de 38 anos, com diagnóstico de HIV há 4 anos e sem TARV há 1 ano, procura atendimento por tosse seca e dispneia progressiva há 3 semanas, com febre baixa vespertina. Nega expectoração purulenta e hemoptise. Exame: T 37,8 °C, FR 24 irpm, FC 104 bpm, PA 118 × 74 mmHg, SpO2 94% em ar ambiente em repouso, que cai para 86% após caminhar no corredor; placas esbranquiçadas removíveis em palato; raros estertores finos bibasais. TC de tórax: opacidades em vidro fosco bilaterais e difusas, com predomínio peri-hilar, e cistos de paredes finas em lobos superiores, sem derrame pleural ou linfonodomegalia. CD4 62 células/mm³, LDH 520 U/L, beta-D-glucana sérica positiva. Gasometria arterial em ar ambiente: pH 7,46, PaO2 66 mmHg, PaCO2 31 mmHg, HCO3 22 mEq/L. Sem alergias conhecidas. Além de sulfametoxazol-trimetoprima, a duração do tratamento e a indicação de corticoide são, respectivamente:

A) 14 dias / não indicado

B) 14 dias / indicado

C) 21 dias / não indicado

D) 21 dias / indicado

---

45 Homem de 38 anos teve HBsAg reagente descoberto há 6 anos em doação de sangue; a mãe tem hepatite B. Assintomático, sem etilismo, IMC 24 kg/m², sem comorbidades e sem uso de medicamentos; não há história familiar de carcinoma hepatocelular. Exame físico normal. Nos últimos 2 anos, quatro dosagens de ALT entre 18 e 26 U/L (referência até 40 U/L). Exames atuais: HBeAg não reagente, anti-HBe reagente, HBV-DNA 410 UI/mL, plaquetas 236.000/mm³; anti-HCV, anti-HDV e anti-HIV não reagentes. Elastografia hepática transitória: 4,8 kPa. Ultrassonografia abdominal normal. A conduta mais adequada é:

A) Entecavir até perder o HBsAg

B) Tenofovir por tempo indeterminado

C) Biópsia hepática para estadiamento

D) ALT e HBV-DNA periódicos, sem antiviral

---

46 Homem de 63 anos, com cardiopatia isquêmica (infarto anterior há 6 anos, angioplastia da descendente anterior) e IC de fração de ejeção reduzida em classe funcional II a III da NYHA, sem internação no último ano. Há 5 meses usa, nas doses máximas toleradas e com boa adesão, sacubitril-valsartana 97/103 mg duas vezes ao dia, bisoprolol 10 mg, espironolactona 25 mg e dapagliflozina 10 mg ao dia. Nega síncope e palpitações. Exame: PA 106 × 64 mmHg, FC 62 bpm regular, sem turgência jugular, pulmões limpos, sem edema. Potássio 4,8 mEq/L, creatinina 1,2 mg/dL. ECG: ritmo sinusal, bloqueio de ramo esquerdo com QRS de 158 ms, já presente em traçados de 2 anos atrás. Ecocardiograma de controle: VE dilatado, fração de ejeção de 29% (era 27% antes da otimização), sem trombo. Holter de 24 horas: extrassístoles ventriculares isoladas, sem taquicardia ventricular. A conduta mais adequada é:

A) Cardiodesfibrilador implantável isolado

B) Ressincronizador com desfibrilador

C) Manter o tratamento clínico atual

D) Associar ivabradina

---

47 Homem de 71 anos, hipertenso, diabético e com angioplastia coronária há 3 anos, em uso de AAS, losartana e metformina, acorda com tontura rotatória contínua, náuseas e vômitos, há 14 horas, que pioram com o movimento da cabeça mas não cessam em repouso. Teve infecção de vias aéreas superiores há 9 dias. Nega hipoacusia, zumbido, cefaleia, diplopia, disartria e episódios prévios. PA 164/94 mmHg, FC 88 bpm, ritmo regular, glicemia 168 mg/dL. Exame: nistagmo horizontal-torcional batendo para a direita no olhar primário, que aumenta no olhar para a direita, diminui com a fixação e não muda de direção no olhar para a esquerda; teste do impulso cefálico com sacada corretiva ao girar a cabeça para a esquerda; sem desvio vertical na cobertura alternada; audição simétrica no teste de atrito dos dedos; coordenação apendicular normal; anda sem apoio, com desvio para a esquerda. TC de crânio sem contraste normal. O diagnóstico mais provável é:

A) Vertigem posicional paroxística benigna

B) Infarto cerebelar

C) Neurite vestibular

D) Labirintite viral

---

48 Homem de 67 anos, no sexto dia de internação por peritonite fecal operada, recebeu noradrenalina nos três primeiros dias, suspensa há 72 horas. Evolui com lesão renal aguda: creatinina 0,9 mg/dL na admissão, 3,8 mg/dL no terceiro dia e 6,9 mg/dL hoje; ureia 186 mg/dL. Diurese de 1.350 mL nas últimas 24 horas, sem diurético, com balanço hídrico acumulado de +1.200 mL. Exame: lúcido, sem asterixe, sem atrito pericárdico, PA 128/74 mmHg, FC 88 bpm, SpO2 96% em ar ambiente, murmúrio vesicular sem estertores, edema 1+. Exames: sódio 137 mEq/L, potássio 5,3 mEq/L, bicarbonato 19 mEq/L, pH 7,33, fósforo 5,9 mg/dL, hemoglobina 9,8 g/dL. Quanto à terapia renal substitutiva, a conduta mais adequada é:

A) Hemodiálise intermitente hoje

B) Hemodiálise contínua hoje

C) Não iniciar e reavaliar diariamente

D) Cateter de longa permanência para diálise

---

49 Homem de 29 anos tem doença de Still do adulto diagnosticada há 5 semanas (febre quotidiana, exantema evanescente, artrite de punhos, leucocitose neutrofílica, FAN e FR negativos; infecção e neoplasia afastadas, inclusive por biópsia de linfonodo), em uso de prednisona 40 mg/dia, com melhora inicial. Há 6 dias voltou a ter febre contínua de 39,5 °C, agora sem exantema e sem artrite. Exame físico: PA 102 × 64 mmHg, FC 118 bpm, baço a 4 cm do rebordo costal, sem foco infeccioso aparente. Exames de 3 semanas atrás e de hoje, respectivamente: leucócitos 19.400 e 6.100/mm³; plaquetas 540.000 e 182.000/mm³; Hb 11,2 e 10,1 g/dL; ferritina 6.800 e 41.000 ng/mL; AST 54 e 310 U/L; fibrinogênio 520 e 150 mg/dL; VHS 92 e 30 mm/h. Triglicerídeos 380 mg/dL. Hemoculturas e urocultura negativas após 72 horas, procalcitonina 0,3 ng/mL, PCR para CMV e EBV não detectadas. A conduta mais adequada é:

A) Pulso de metilprednisolona e anakinra

B) Associar metotrexato 15 mg/semana

C) Etoposídeo associado a dexametasona

D) Manter prednisona e reavaliar em 1 semana

---

50 Mulher de 34 anos, previamente hígida, é admitida com gengivorragia e equimoses extensas há 3 dias. Exame: PA 118 × 74 mmHg, FC 104 bpm, equimoses em tronco e membros, sem esplenomegalia. Exames: Hb 7,8 g/dL, leucócitos 1.900/mm³, plaquetas 18.000/mm³, INR 1,7, TTPa 38 s (controle 30 s), fibrinogênio 85 mg/dL, D-dímero muito elevado. Esfregaço de sangue periférico: células imaturas com granulação grosseira, núcleo bilobulado e múltiplos bastonetes de Auer em feixes. Foi coletado sangue para RT-PCR de PML-RARA e cariótipo, com resultado previsto em 72 horas; o mielograma está agendado para amanhã. Além de crioprecipitado e transfusão de plaquetas, a conduta mais adequada neste momento é:

A) Iniciar ácido all-trans retinoico já

B) Aguardar o PML-RARA para iniciar ATRA

C) Iniciar ATRA após o mielograma

D) Indução com citarabina e antraciclina

---

51 Homem de 62 anos, tabagista de 40 maços-ano, com DPOC GOLD 2 em uso de tiotrópio, procura atendimento por tosse seca persistente, febre baixa, cefaleia e mal-estar há 9 dias; há 3 dias notou urina escura e cansaço desproporcional. A neta de 15 anos, que mora com ele, teve quadro respiratório semelhante há 3 semanas. Exame: T 37,9 °C, FR 20 irpm, FC 96 bpm, PA 128 × 80 mmHg, SpO2 94% em ar ambiente, mucosas descoradas 2+/4+ e ictéricas 1+/4+, estertores finos em base esquerda; orientado. Radiografia: infiltrado reticulonodular em lobo inferior esquerdo, sem consolidação lobar. Hb 9,1 g/dL, reticulócitos 6%, leucócitos 9.800/mm³, bilirrubina indireta 2,8 mg/dL, LDH 640 U/L, haptoglobina indetectável, ureia 34 mg/dL. O esfregaço mostra aglutinação de hemácias à temperatura ambiente. Teste de antiglobulina direto positivo para C3d e negativo para IgG. O antimicrobiano mais adequado é:

A) Amoxicilina-clavulanato

B) Cefuroxima

C) Azitromicina

D) Ceftriaxona

---

52 Mulher de 58 anos, no 9º dia de pós-operatório de artroplastia de quadril, apresenta dispneia súbita e dor pleurítica. Exame: PA 112 × 70 mmHg (habitual 130 × 80 mmHg), FC 112 bpm, FR 24 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, sem sinais de hipoperfusão, diurese preservada. Lactato 1,6 mmol/L. Angiotomografia: falhas de enchimento em ambas as artérias pulmonares principais, com relação VD/VE de 1,3. Troponina I ultrassensível 96 ng/L (VR até 16). Na hora seguinte, sob heparina não fracionada, mantém PA sistólica entre 104 e 112 mmHg. A classificação de risco e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Alto / trombólise sistêmica imediata

B) Alto / anticoagulação e monitorização

C) Intermediário-alto / trombólise sistêmica imediata

D) Intermediário-alto / anticoagulação e monitorização

---

53 Mulher de 44 anos, técnica de enfermagem em enfermaria de clínica médica, sem diabetes, é levada ao pronto-socorro pela terceira vez em dois meses por sudorese, confusão e fala arrastada, que melhoram com glicose venosa. Mora com a mãe, que tem diabetes tipo 2. Nega etilismo, emagrecimento ou uso de medicamentos. Exame: IMC 24 kg/m², sem alterações. No episódio de hoje, antes da glicose: glicemia 36 mg/dL, insulina 28 µUI/mL (na hipoglicemia, abaixo de 3), peptídeo C 3,9 ng/mL (abaixo de 0,6), pró-insulina 14 pmol/L (abaixo de 5), beta-hidroxibutirato 0,1 mmol/L (acima de 2,7), anticorpo anti-insulina negativo. Creatinina, cortisol e função hepática normais. O próximo passo mais adequado é:

A) Dosagem de sulfonilureias no plasma

B) Jejum supervisionado de 72 horas

C) Ecoendoscopia pancreática

D) Tomografia de pâncreas com contraste

---

54 Homem de 63 anos, tabagista ativo de 40 maços-ano, assintomático, fez exames de rotina em check-up particular, que incluíram antígeno carcinoembrionário (CEA) de 6,1 ng/mL (referência até 5,0 ng/mL). Colonoscopia de rastreamento há 2 anos sem pólipos. TC de tórax de baixa dose, feita no programa de rastreamento de câncer de pulmão há 4 meses: Lung-RADS 1. Sem perda de peso, sem alteração do hábito intestinal, sem anemia; hemograma e funções hepática e renal normais; exame físico normal. Diante do CEA, a conduta mais adequada é:

A) PET-CT de corpo inteiro

B) Nenhum exame adicional pelo CEA

C) TC de tórax, abdome e pelve

D) Nova colonoscopia

---

55 Mulher de 46 anos refere dor e edema em mãos e pés há 8 meses, com rigidez matinal de 40 minutos. Nos últimos 2 meses, o terceiro pododáctilo direito ficou inteiro edemaciado e doloroso. A mãe tem nódulos nos dedos desde os 50 anos. Usa apenas dipirona. Exame físico: artrite das interfalângicas distais do 2º e 3º dedos da mão direita e da interfalângica proximal do 4º dedo esquerdo, poupando as demais, edema difuso e doloroso de todo o terceiro pododáctilo direito, depressões puntiformes em 4 unhas com onicólise distal, e placa eritematodescamativa de 3 cm na fenda interglútea, que a paciente atribuía a micose. Exames: VHS 38 mm/h, PCR 2,1 mg/dL, fator reumatoide 24 UI/mL (VR < 14), anti-CCP não reagente, ácido úrico 5,8 mg/dL. Radiografia de mãos: erosão em interfalângica distal com proliferação óssea adjacente. O diagnóstico mais provável é:

A) Osteoartrite erosiva de mãos

B) Gota poliarticular

C) Artrite psoriásica

D) Artrite reumatoide soropositiva

---

56 Mulher de 58 anos, professora, é trazida pelo marido porque, nos últimos 4 meses, gastou as economias do casal em apostas on-line e passou a comprar compulsivamente roupas que não usa; ela minimiza o problema. Há 14 meses iniciou tratamento para desconforto nas pernas ao deitar, com necessidade de movê-las, que melhorava ao caminhar; a dose do medicamento foi aumentada há 6 meses, com bom controle. Nega episódios prévios de humor elevado, redução da necessidade de sono, uso de álcool e história familiar psiquiátrica. Exame neurológico normal, sem parkinsonismo. Mini-exame do estado mental 29. Ferritina 110 ng/mL. A causa mais provável do comportamento atual é:

A) Efeito adverso de agonista dopaminérgico

B) Episódio hipomaníaco de transtorno bipolar

C) Demência frontotemporal, variante comportamental

D) Fenômeno de aumento (augmentation)

---

57 Homem de 71 anos, com IC de fração de ejeção reduzida (FE 25%) e cardiodesfibrilador implantável, em uso de sacubitril-valsartana, espironolactona, carvedilol e dapagliflozina, e doença renal crônica com creatinina basal de 1,8 mg/dL, teve diarreia aquosa por 4 dias com pouca ingesta. É levado à emergência por fraqueza e perde a consciência na triagem. Monitor: ritmo organizado com QRS de 200 ms, a 40 bpm, sem pulso central palpável. O cardiodesfibrilador não disparou. Iniciadas compressões e adrenalina. Glicemia capilar 132 mg/dL. Antes da parada não havia turgência jugular, e não há trauma. A causa mais provável da parada é:

A) Síndrome coronariana aguda

B) Tromboembolismo pulmonar

C) Hipercalemia

D) Hipovolemia

---

58 Homem de 41 anos, vivendo com HIV há 2 anos, em uso regular do esquema antirretroviral inicial preconizado pelo Ministério da Saúde (um comprimido de tenofovir com lamivudina e um comprimido do terceiro fármaco, ambos uma vez ao dia), tem carga viral indetectável e CD4 410 células/mm³. Há 5 semanas apresenta tosse produtiva, febre vespertina e perda de 5 kg. Radiografia: cavitação em ápice direito. TRM-TB no escarro: M. tuberculosis detectado, sem resistência à rifampicina. Creatinina 0,9 mg/dL, ALT 28 U/L. Inicia-se RHZE em dose plena por peso. Em relação ao esquema antirretroviral, a conduta mais adequada é:

A) Manter o esquema sem alteração

B) Trocar o terceiro fármaco por efavirenz

C) Substituir rifampicina por rifabutina

D) Dolutegravir 50 mg de 12/12 horas

---

59 Mulher de 46 anos, com síndrome de Sjögren primária (anti-Ro reagente) há seis anos, em uso de hidroxicloroquina, procura atendimento por fraqueza e cãibras há três semanas. Há cinco semanas toma diariamente um chá de sene para emagrecer, com quatro a cinco evacuações amolecidas por dia. Nega litíase renal. Exame: PA 108/70 mmHg, FC 96 bpm, sem edema. Exames séricos: sódio 137 mEq/L, potássio 2,9 mEq/L, cloro 114 mEq/L, bicarbonato 14 mEq/L, pH 7,29, pCO2 30 mmHg, albumina 4,0 g/dL, creatinina 0,8 mg/dL. Urina de amostra: pH 6,0, sódio 38 mEq/L, potássio 30 mEq/L e cloro 92 mEq/L. A causa mais provável da acidose é:

A) Acidose tubular renal proximal (tipo 2)

B) Acidose tubular renal distal (tipo 1)

C) Perda intestinal de bicarbonato

D) Acidose tubular renal tipo 4

---

60 Mulher de 82 anos, viúva há 3 meses, está no 3º dia de pós-operatório de fratura de fêmur. Antes da queda era independente, administrava as próprias finanças e teve MEEM de 28 pontos há 6 meses. Usa tramadol para a dor e oxibutinina, iniciada ontem por urgência miccional após retirada da sonda. Desde ontem passa a maior parte do dia sonolenta, responde com monossílabos, não consegue dizer os meses do ano de trás para frente e em alguns momentos não reconhece a filha, mas no fim da tarde conversou normalmente. A filha diz que "a mãe está deprimida pela viuvez". Não apresenta agitação, alucinações ou febre. Exame: PA 132 × 74 mmHg, FC 86 bpm, SpO2 95%, sem déficit focal. Glicemia 118 mg/dL, Na 137 mEq/L. O diagnóstico mais provável é:

A) Episódio depressivo maior

B) Demência com corpos de Lewy

C) Delirium hipoativo

D) Doença de Alzheimer

---

61 Mulher de 54 anos, submetida a derivação gástrica em Y de Roux há 9 anos, procura atendimento por cansaço progressivo e formigamento nos pés há 6 meses, com desequilíbrio ao andar no escuro. Usa polivitamínico de forma irregular e, por conta própria, comprimidos de zinco 50 mg/dia há 2 anos "para a imunidade". Exame: hipocorada 2+/4, Romberg positivo, reflexos patelares vivos, sensibilidade vibratória abolida até os joelhos. Exames: Hb 8,4 g/dL, VCM 101 fL, reticulócitos 0,6%, leucócitos 2.100/mm³ (neutrófilos 700/mm³), plaquetas 198.000/mm³, vitamina B12 610 pg/mL, ácido metilmalônico normal, folato e TSH normais. Mielograma: vacuolização citoplasmática em precursores eritroides e mieloides, sideroblastos em anel em 18% dos eritroblastos, displasia discreta e blastos 1%. O próximo exame mais adequado é:

A) Ressonância de medula cervical

B) Cariótipo de medula óssea

C) Pesquisa de mutação SF3B1

D) Cobre sérico e ceruloplasmina

---

62 Homem de 58 anos, tabagista de 50 maços-ano, há 3 semanas tem edema progressivo de face e pescoço, pletora facial e turgência das veias do tórax, piores ao deitar. Sem estridor, sem rouquidão, sem cefaleia, confusão ou síncope. Exame: FR 18 irpm, SpO2 95% em ar ambiente, PA 136 × 84 mmHg, sem tiragem; linfonodo supraclavicular direito de 1,8 cm, endurecido. TC de tórax: massa mediastinal anterior e paratraqueal direita de 7 cm comprimindo a veia cava superior, com colaterais, sem compressão traqueal significativa. Não há diagnóstico histológico e ele não recebeu corticoide. O próximo passo mais adequado é:

A) Stent endovascular imediato

B) Dexametasona intravenosa imediata

C) Biópsia do linfonodo supraclavicular

D) Radioterapia mediastinal de urgência

---

63 Mulher de 41 anos, com doença de Graves de difícil controle (T3 total de 520 ng/dL na última consulta, apesar de metimazol 40 mg/dia) e fosfatase alcalina de 410 U/L no pré-operatório, foi submetida a tireoidectomia total sem intercorrências, com identificação e preservação das quatro paratireoides descritas pelo cirurgião. No segundo dia pós-operatório refere parestesias periorais e nas mãos. Exame: sinal de Chvostek positivo, ferida sem hematoma, voz normal. Exames: cálcio total 7,1 mg/dL (8,5 a 10,2), albumina 3,9 g/dL, fósforo 1,9 mg/dL (2,5 a 4,5), magnésio 1,5 mg/dL (1,7 a 2,4), PTH 112 pg/mL (15 a 65), 25-hidroxivitamina D 32 ng/mL. A causa mais provável da hipocalcemia é:

A) Hipoparatireoidismo pós-cirúrgico

B) Hipomagnesemia

C) Síndrome da fome óssea

D) Deficiência de vitamina D

---

64 Mulher de 31 anos, previamente hígida, com beta-HCG negativo, procura o pronto-socorro com febre de 39,4 °C, calafrios, disúria e dor lombar direita há 2 dias. Teve um episódio de cistite há 5 meses, tratado com nitrofurantoína. Nega cálculo urinário, diabetes ou uso recente de antibiótico. Tolera dieta e medicação oral, sem vômitos. Exame: T 38,9 °C, FC 98 bpm, PA 118 × 76 mmHg, FR 16 irpm, bom estado geral, punho-percussão lombar dolorosa à direita, abdome sem defesa. Leucócitos 17.600/mm³ com 8% de bastões, PCR 18 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. EAS com piócitos incontáveis, nitrito positivo e hematúria microscópica. Após dipirona, fica afebril e sem dor. Antes da primeira dose de antibiótico, a investigação complementar mais adequada é:

A) Urocultura, apenas

B) Urocultura e TC de abdome

C) Urocultura e ultrassonografia renal

D) Hemoculturas e urocultura

---

65 Mulher de 76 anos, hipertensa e diabética tipo 2 (HbA1c 7,4%), procura o pronto-socorro por cefaleia temporal direita há 3 semanas, dor na mandíbula ao mastigar e dor e rigidez nos ombros pela manhã. Ontem teve dois episódios de perda visual monocular direita, indolor, que duraram 5 minutos cada e reverteram totalmente. Exame físico: PA 150 × 86 mmHg, artéria temporal direita espessada, dolorosa e sem pulso, acuidade visual normal, fundoscopia sem edema de papila. Exames: VHS 96 mm/h, PCR 8,4 mg/dL, plaquetas 520.000/mm³, glicemia 210 mg/dL. Ultrassonografia de artérias temporais e biópsia só estão disponíveis no ambulatório do hospital em 5 dias. A dose inicial do glicocorticoide e o momento de iniciá-lo são, respectivamente:

A) Pulso de metilprednisolona / agora

B) Pulso de metilprednisolona / após a biópsia

C) Prednisona 15 mg/dia / agora

D) Prednisona 15 mg/dia / após a biópsia

---

66 Mulher de 34 anos com doença de Crohn ileal foi submetida há 5 meses a ressecção ileocecal de 60 cm por estenose e está em uso de adalimumabe desde então. Há 4 meses tem 5 a 7 evacuações aquosas por dia, sobretudo após as refeições, sem sangue, sem despertar noturno para evacuar e sem febre; o peso está estável e as fezes não têm gordura visível nem odor fétido. Exame: IMC 22 kg/m², abdome indolor, cicatriz sem fístula. Exames: hemoglobina 12,8 g/dL, PCR 3 mg/L, calprotectina fecal 42 µg/g, albumina 4,1 g/dL, vitamina B12 360 pg/mL. Pesquisa de toxinas de C. difficile negativa. Ileocolonoscopia: anastomose íleo-cólica com mucosa íntegra (Rutgeerts i0). A causa mais provável da diarreia é:

A) Esteatorreia por depleção de sais biliares

B) Má absorção de ácidos biliares

C) Recidiva pós-operatória do Crohn

D) Supercrescimento bacteriano do delgado

---

67 Pela Resolução CFM nº 2.173/2017, no paciente em coma não perceptivo após parada cardiorrespiratória, com encefalopatia hipóxico-isquêmica como causa, o tempo mínimo de tratamento e observação hospitalar antes de iniciar os procedimentos de determinação de morte encefálica é de:

A) 6 horas
B) 12 horas
C) 24 horas
D) 72 horas

---

68 A lesão valvar e o distúrbio do sistema de condução mais associados à espondilite anquilosante são, respectivamente:

A) Estenose mitral / fibrilação atrial
B) Insuficiência aórtica / pré-excitação ventricular
C) Insuficiência aórtica / bloqueio atrioventricular
D) Estenose aórtica / bloqueio atrioventricular

---

69 Homem de 19 anos, previamente hígido, teve lesões crostosas e purulentas nas pernas há três semanas, tratadas com pomada. Há quatro dias nota urina escura, inchaço nas pálpebras e cefaleia. Exame: PA 162/100 mmHg, FC 76 bpm, edema 1+ em membros inferiores, sem estertores, sem lesões cutâneas ativas, sem artrite, sem úlceras orais. Exames: creatinina 1,6 mg/dL na admissão e 1,5 mg/dL após 48 horas, potássio 4,9 mEq/L, hemograma normal; urina com proteína 2+, 80 hemácias por campo, 70% dismórficas, e cilindros hemáticos; relação proteína/creatinina urinária de 1,1 g/g; anti-DNase B 960 U/mL (até 200); C3 38 mg/dL (90 a 180) e C4 24 mg/dL (10 a 40); FAN reagente 1:80, padrão nuclear pontilhado fino; anti-DNA não reagente. Diurese de 900 mL/dia com furosemida e restrição de sódio. Além do suporte, o próximo passo é:

A) Biópsia renal percutânea
B) Pulsoterapia com metilprednisolona
C) Dosar ANCA e anti-MBG
D) Repetir C3 em oito semanas

---

70 Homem de 71 anos, com leucemia linfocítica crônica tratada há 8 meses com esquema que incluiu fludarabina, vai receber concentrado de hemácias por anemia sintomática. Não tem antecedente de reação transfusional nem deficiência de IgA. No hemocentro, todos os concentrados de hemácias já são desleucocitados por filtração. Quanto à irradiação e à lavagem do hemocomponente, respectivamente:

A) Indicada / indicada
B) Indicada / dispensável
C) Dispensável / indicada
D) Dispensável / dispensável

---

71 Homem de 66 anos, ex-tabagista (45 maços-ano, parou há 6 anos), com DPOC leve e tuberculose pulmonar tratada há 30 anos, faz TC de tórax de rastreio. Há nódulo sólido de 24 mm, espiculado, no segmento anterior do lobo superior direito, ausente em TC de 2 anos atrás, e estrias fibróticas apicais bilaterais antigas. PET-CT: captação no nódulo (SUV máximo 7,8), sem captação em linfonodos hilares, mediastinais ou à distância; linfonodos mediastinais menores que 1 cm na TC. Baciloscopia e teste rápido molecular no escarro negativos. Espirometria: VEF1 78% do previsto; DLCO 72%. Sem dispneia, ECOG 0. A conduta mais adequada é:

A) Biópsia transtorácica guiada por TC

B) Ecobroncoscopia com punção mediastinal

C) Ressecção anatômica sem biópsia prévia

D) TC de tórax de controle em 3 meses

---

72 Homem de 63 anos, hipertenso em losartana, é trazido ao pronto-socorro com cefaleia retro-orbitária súbita e intensa há seis horas, seguida de vômitos e visão dupla. Sem trauma, sem febre. Refere há um ano redução de libido e cansaço, não investigados. Exame: sonolento, mas orientado, PA 88/54 mmHg, FC 112 bpm, T 37,2 °C, ptose palpebral e midríase à direita, hemianopsia bitemporal à confrontação, sem rigidez de nuca. Exames: sódio 127 mEq/L, potássio 4,3 mEq/L, glicemia 68 mg/dL, creatinina 1,2 mg/dL. Tomografia de crânio: massa selar de 2,6 cm com área hiperdensa e extensão suprasselar, sem hemorragia subaracnóidea. Colhido sangue para cortisol, TSH, T4 livre e prolactina. A conduta imediata mais adequada é:

A) Hidrocortisona venosa em dose de estresse

B) Descompressão transesfenoidal de urgência

C) Angiotomografia arterial cerebral

D) Cabergolina em dose alta

---

73 Mulher de 63 anos, no 18º dia de pós-operatório de colectomia por adenocarcinoma de cólon complicada por fístula enterocutânea, recebe nutrição parenteral total por cateter venoso central em subclávia direita há 14 dias e tem sonda vesical de demora. Há 2 dias tem febre de até 38,7 °C com calafrios. Exame: FC 108 bpm, PA 112 × 70 mmHg, óstio do cateter sem hiperemia ou secreção, abdome sem sinais de peritonite, débito da fístula estável. Radiografia de tórax: atelectasia laminar em base esquerda. EAS com 40 leucócitos por campo e urocultura com mais de 100.000 UFC/mL de Candida sp. TC de abdome sem coleções. Foram colhidas ao mesmo tempo, com o mesmo volume, uma hemocultura pelo cateter e outra por punção periférica, e ambas cresceram Candida parapsilosis: a do cateter positivou com 9 horas de incubação e a periférica, com 13 horas. O diagnóstico mais provável é:

A) Candidíase invasiva de origem abdominal

B) Infecção de corrente sanguínea pelo cateter

C) Candidemia de foco urinário

D) Colonização do cateter, sem infecção

---

74 Homem de 61 anos, com cirrose por vírus C (Child-Pugh B) e ascite em uso de diuréticos, procura a emergência com dor abdominal difusa e febre há 2 dias. Nega sangramento. Exame: Tax 38,4 °C, FC 108 bpm, PA 104 × 64 mmHg, ascite moderada, abdome doloroso difusamente, sem defesa localizada. Exames: leucócitos 16.200/mm³, creatinina 1,3 mg/dL, glicose sérica 110 mg/dL, DHL sérica 210 U/L (referência até 250 U/L). Paracentese: líquido turvo, 6.800 células/mm³ com 88% de polimorfonucleares, proteína total 2,6 g/dL, glicose 22 mg/dL, DHL 480 U/L; Gram com bacilos gram-negativos, cocos gram-positivos e bacilos gram-positivos. O diagnóstico mais provável é:

A) Ascite neutrocítica cultura-negativa

B) Bacterascite monomicrobiana

C) Peritonite bacteriana secundária

D) Peritonite bacteriana espontânea

---

75 Mulher de 27 anos tem lúpus eritematoso sistêmico há 3 anos (artrite, lúpus cutâneo subagudo, anti-DNA nativo reagente), em uso de hidroxicloroquina 400 mg/dia, com artrite e pele controladas há 1 ano. Vem à consulta de rotina, sem queixas. PA 118 × 74 mmHg, sem edema. Exames: creatinina 0,7 mg/dL, EAS com 12 hemácias por campo, dismórficas, sem cilindros, relação proteína/creatinina urinária de 0,7 g/g confirmada em segunda amostra, C3 78 mg/dL (VR 90 a 180), C4 9 mg/dL (VR 10 a 40), anti-DNA nativo 1:80. Biópsia renal: 24 glomérulos com hipercelularidade e expansão mesangiais, imunofluorescência com depósitos mesangiais de IgG, IgA, IgM, C3 e C1q, microscopia eletrônica sem depósitos subendoteliais ou subepiteliais, sem crescentes, necrose ou proliferação endocapilar. Além de manter a hidroxicloroquina, a conduta mais adequada é:

A) Pulso de metilprednisolona e ciclofosfamida

B) Micofenolato e prednisona em dose alta

C) Bloqueio do eixo renina-angiotensina e seguimento

D) Belimumabe associado a micofenolato

---

76 Homem de 55 anos, com IMC de 33 kg/m², diabetes tipo 2 em metformina, hipertrigliceridemia e esteatose hepática, não bebe. Em outro serviço, por ferritina de 1.240 ng/mL, iniciou flebotomias semanais de 450 mL há 6 semanas, com a meta escrita de "retirar sangue até a ferritina chegar a 50". Não foi feita pesquisa genética. Exames antes da primeira sessão: hemoglobina 15,6 g/dL, saturação de transferrina 38%. Desde a 4ª sessão refere cansaço e tontura ao levantar. Exames de hoje, após 6 sessões: hemoglobina 11,9 g/dL, VCM 83 fL, ferritina 860 ng/mL, saturação de transferrina 12%, ALT 58 U/L, PCR 0,8 mg/dL. Quanto às flebotomias, a conduta mais adequada é:

A) Trocar por quelante oral de ferro

B) Suspender as flebotomias

C) Espaçar para uma sessão mensal

D) Manter até ferritina de 50 a 100

---

77 Mulher de 81 anos, com doença de Alzheimer leve diagnosticada há 2 anos, em uso de donepezila 10 mg/dia, mora com a filha e era independente para banho e alimentação. Há 6 dias, a urologista prescreveu oxibutinina 5 mg três vezes ao dia por urgência miccional. Há 3 dias está sonolenta durante o dia e agitada à noite, quando diz ver pessoas estranhas no quarto; alterna momentos de lucidez com outros em que não reconhece a filha e não consegue manter a atenção para dizer os meses do ano de trás para frente. Exame: Tax 36,6 °C, PA 128/76 mmHg, mucosas secas, sem rigidez, tremor ou déficit focal. Glicemia 112 mg/dL, sódio 137 mEq/L, hemograma e EAS normais, sem resíduo vesical na ultrassonografia após micção. A causa mais provável do quadro atual é:

A) Progressão da doença de Alzheimer

B) Demência com corpos de Lewy

C) Infarto lacunar talâmico

D) Delirium por efeito anticolinérgico

---

78 Mulher de 46 anos, com diagnóstico de asma feito há 8 meses num pronto-atendimento, procura o ambulatório porque a falta de ar não melhorou com budesonida-formoterol em dose média, usado com técnica correta. Refere chiado e ruído alto na inspiração ao subir escadas, rouquidão discreta e engasgos com líquidos desde uma tireoidectomia total por bócio multinodular, há 1 ano. Nega tosse noturna, rinite e piora com poeira ou frio. Eosinófilos 90/mm³. Exame: FR 18 irpm, SpO2 97% em ar ambiente, ruído inspiratório audível sobre a região cervical, pulmões sem sibilos expiratórios. Radiografia de tórax normal. Na curva fluxo-volume, o achado esperado é:

A) Achatamento das alças inspiratória e expiratória

B) Achatamento isolado da alça inspiratória

C) Achatamento isolado da alça expiratória

D) Concavidade da alça expiratória

---

79 Homem de 58 anos, hipertenso e ex-tabagista, teve infarto sem supradesnivelamento de ST há 5 meses, tratado com angioplastia da descendente anterior. Não é diabético, não tem doença arterial periférica nem cerebrovascular e não teve outro evento. Usa rosuvastatina 40 mg ao dia desde a alta, com boa adesão e sem mialgia, e nunca usou outro hipolipemiante. Perfil lipídico: colesterol total 136 mg/dL, HDL 40 mg/dL, triglicerídeos 160 mg/dL, LDL 64 mg/dL (antes da estatina, 158 mg/dL). CK e transaminases normais, TFG 74 mL/min. A conduta mais adequada para o LDL neste momento é:

A) Associar ezetimiba 10 mg

B) Associar inibidor de PCSK9

C) Trocar por atorvastatina 80 mg

D) Manter e repetir em 6 meses

---

80 Homem de 70 anos, com diabetes tipo 2 em uso de metformina e TFGe estável de 48 mL/min/1,73 m², sem lesão renal aguda atual, fará tomografia de abdome com contraste iodado intravenoso para estadiamento ambulatorial de neoplasia de cólon. Para prevenção de lesão renal associada ao contraste, a conduta mais adequada é:

A) Bicarbonato de sódio intravenoso

B) N-acetilcisteína oral

C) Hidratação venosa com SF 0,9%

D) Nenhuma profilaxia específica

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 2

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)	51 (A) (B) (C) (D)	52 (A) (B) (C) (D)
53 (A) (B) (C) (D)	54 (A) (B) (C) (D)	55 (A) (B) (C) (D)	56 (A) (B) (C) (D)
57 (A) (B) (C) (D)	58 (A) (B) (C) (D)	59 (A) (B) (C) (D)	60 (A) (B) (C) (D)
61 (A) (B) (C) (D)	62 (A) (B) (C) (D)	63 (A) (B) (C) (D)	64 (A) (B) (C) (D)
65 (A) (B) (C) (D)	66 (A) (B) (C) (D)	67 (A) (B) (C) (D)	68 (A) (B) (C) (D)
69 (A) (B) (C) (D)	70 (A) (B) (C) (D)	71 (A) (B) (C) (D)	72 (A) (B) (C) (D)
73 (A) (B) (C) (D)	74 (A) (B) (C) (D)	75 (A) (B) (C) (D)	76 (A) (B) (C) (D)
77 (A) (B) (C) (D)	78 (A) (B) (C) (D)	79 (A) (B) (C) (D)	80 (A) (B) (C) (D)